



THE ULTIMATE ACADEMY



RUN GUIDE

ANTI-BLESSURE

Prévenir, détecter et soigner
les blessures du coureur

 8 Blessures

 10 Exercices

 Étirements

 Protocoles

THEULTIMATEACADEMY.FR



Sommaire

Introduction	3
Les 8 blessures du coureur — Partie 1/2	4
Les 8 blessures du coureur — Partie 2/2	5
Programme de renforcement — Partie 1	6
Programme de renforcement — Partie 2	7
Étirements essentiels	8
Gestion de la charge d'entraînement	9
Protocole PEACE & LOVE	10
Chaussures et matériel	11
Passer à l'action	12

Introduction

Courir est l'une des activités les plus naturelles qui soit. Pourtant **65% des coureurs se blessent chaque année**, souvent pour des raisons évitables avec un peu de méthode et de régularité dans la prévention.

65%des coureurs se blessent
chaque année**3×**plus lent : adaptation des
tendons vs muscles**10%**d'augmentation de charge
max par semaine**2×**plus de risques avec moins de
7h de sommeil**Progression trop rapide**

L'erreur la plus fréquente. Les tendons s'adaptent 3 fois plus lentement que les muscles. Augmente toujours ta charge par paliers de 10% maximum.

**Manque de renforcement**

Un coureur qui ne fait que courir accumule des déséquilibres dangereux. Fessiers, tibialis et gainage insuffisants exposent genoux et chevilles.

**Récupération négligée**

La performance se construit pendant le repos. Moins de 7h de sommeil par nuit multiplie par deux le risque de blessure selon les études.

**Équipement inadapté**

Une chaussure usée ou mal adaptée crée des douleurs sur toute la chaîne cinétique. La rotation de deux paires réduit de 40% le risque de blessure.

3 RÈGLES POUR NE PLUS SE BLESSER

 **Écoute ton corps** : une douleur qui dure plus de 3 jours n'est pas anodine. 3 jours de repos valent mieux que 3 mois d'arrêt.

 **Planifie la récupération** comme une séance : elle fait partie de l'entraînement au même titre qu'un fractionné.

 **2 séances de renforcement/semaine** suffisent pour diviser par trois le risque de blessure sur la saison.

Ce guide est le fruit d'années d'expérience avec des coureurs de tous niveaux. Les protocoles sont issus des **dernières recherches en médecine du sport**. Utilise-le comme référence : consulte la fiche blessure dès les premiers signaux, avant que la douleur ne s'installe.

Les 8 blessures du coureur



Périostite tibiale

Syndrome de stress du tibia

SYMPTÔMES

Douleur diffuse le long du tibia, aggravée à l'effort et au début de séance.

PRÉVENTION

Progression de 10% max/semaine. **Renforcement du tibialis** et du mollet. Varier les surfaces.

TRAITEMENT

Repos relatif 2 sem., glace 15 min × 3/j. Reprise progressive sur surfaces souples.

Débutants



Tendinite d'Achille

Tendinopathie calcanéenne

SYMPTÔMES

Raideur matinale au talon, douleur à la palpation, gonflement possible.

PRÉVENTION

Montées excentriques sur marche (protocole Alfredson). Échauffement 15 min.

TRAITEMENT

Repos 2 à 4 sem., massage transverse profond, kinésithérapie précoce.

Coureurs confirmés



Syndrome de l'essuie-glace

Bandelette ilio-tibiale (BIT)

SYMPTÔMES

Douleur vive face externe du genou après 20 à 30 min d'effort continu.

PRÉVENTION

Renforcement des fessiers et abducteurs. Foam roller BIT. Cadence 175+ pas/min.

TRAITEMENT

Arrêt dès la douleur. AINS si besoin. Kiné pour bilan biomécanique.

Longue distance



Fasciite plantaire

Aponévrosite plantaire

SYMPTÔMES

Douleur intense sous le pied au lever du lit, talon et voûte plantaire.

PRÉVENTION

Renforcement intrinsèque du pied, semelles si besoin, étirements du mollet.

TRAITEMENT

Étirements fascia + mollet, botte de nuit, ondes de choc si chronique.

Route et piste

Les 8 blessures du coureur



Claquage musculaire

Déchirure de fibre ou de faisceau

SYMPTÔMES

Douleur brutale type "coup de couteau", contracture immédiate, hématome possible.

PRÉVENTION

Échauffement 15 min minimum. Hydratation optimale, récupération respectée.

TRAITEMENT

Arrêt immédiat. Protocole PEACE & LOVE (p.10). Pas de chaleur les 72 premières heures.

Séances intenses



Syndrome fémoro-patellaire

Genou du coureur

SYMPTÔMES

Douleur sous ou autour de la rotule, aggravée en descente et assis prolongé.

PRÉVENTION

Squats et fentes unilatéraux. Travail de la hanche. Réduction du volume.

TRAITEMENT

Repos relatif, glace, kiné pour rééquilibrage. Taping rotulien si besoin.

Tous niveaux



Fracture de stress

Ostéopathie de contrainte

SYMPTÔMES

Douleur localisée précise sur le tibia ou métatarses, aggravée à la percussion.

PRÉVENTION

Apports calciques et vitamine D. Augmentation de volume très progressive.

TRAITEMENT

Arrêt complet 6 à 12 sem. IRM ou scintigraphie indispensable. Reprise médicale.

Kilométrage élevé



Tendinopathie de la hanche

Psoas ou moyen fessier

SYMPTÔMES

Douleur profonde à l'aîne ou face latérale hanche, en côte ou début de séance.

PRÉVENTION

Gainage et renforcement fessiers. Étirements psoas après chaque séance.

TRAITEMENT

Repos relatif, kiné, exercices excentriques. Infiltration si chronicité > 3 mois.

Trail et côtes

Programme de renforcement

2 séances/semaine suffisent pour construire une armure musculaire solide. Cible les zones les plus sollicitées en course.
Récupération : 60 à 90 sec entre les séries.


01

Squat unilatéral

Quadriceps · fessiers · stabilisateurs

3 × 12 reps

Debout sur une jambe, descends lentement à 90°. Genou dans l'axe du pied. Remonte en contrôlant.

Conseil : Version avancée : squat bulgare pied arrière surélevé


02

Hip thrust

Grand fessier · ischio-jambiers

3 × 15 reps

Dos sur banc, pieds à plat, pousse le bassin vers le haut. Contraction forte des fessiers. Pause 1 sec.

Conseil : Capital pour prévenir toutes les blessures au genou


03

Mollet excentrique

Soléaire · gastrocnémien · Achille

3 × 15 lentes

Monte sur deux pieds depuis une marche, redescends lentement sur une jambe en 4 secondes.

Conseil : Prophylaxie n°1 contre la tendinite d'Achille


04

Fente marchée

Quadriceps · fessiers · soléaire

3 × 10/côté

Pas en avant, genou avant à 90°, genou arrière effleure le sol. Pousse sur le talon pour remonter.

Conseil : Améliore l'équilibre dynamique du coureur


05

Pont fessier

Grand fessier · core · ischios

3 × 20 reps

Allongé dos au sol, genoux à 90°, pousse le bassin vers le haut. Tiens 2 sec, redescends lentement.

Conseil : Version avancée : une jambe tendue en alternance

Programme de renforcement



06

Clam shell

Moyen fessier · abducteurs

3 × 20/côté

Allongé sur le côté, hanches à 60°. Ouvre le genou supérieur comme une palourde. Lent et contrôlé.

Conseil : Prévient le syndrome de l'essuie-glace



07

Planche latérale

Obliques · carré lombaire · abducteurs

3 × 30 sec

Sur l'avant-bras, corps aligné. Hanches hautes, ne laisse pas la hanche s'affaisser.

Conseil : Progression : levée de la jambe supérieure



08

Tibialis raise

Tibial antérieur · extenseurs orteils

3 × 20 reps

Dos contre un mur, talons à 30 cm. Lève la pointe des pieds vers le haut, talons au sol. Lent.

Conseil : Prévention directe de la périostite tibiale



09

Copenhagen plank

Adducteurs · core · stabilisateurs

3 × 20 sec

Planche latérale, pied supérieur sur banc. Soulève la hanche inférieure en pont. Respire normalement.

Conseil : Un des meilleurs exercices de prévention globale



10

Chaise au mur

Quadriceps · rotule · isométrique

3 × 45 sec

Dos contre le mur, genoux à 90°. Tiens la position. La brûlure dans les quadriceps est normale.

Conseil : Prévient le syndrome fémoro-patellaire

Étirements essentiels

Uniquement **après l'effort**, jamais à froid. Tiens chaque position sans rebonds, en respirant lentement. La régularité quotidienne prime sur l'intensité.



Quadriceps

Face avant de la cuisse

30 sec × 3

Debout sur une jambe, saisir le pied derrière, ramener le talon vers la fesse. Genou vers le bas, bassin neutre. Respire lentement.

Note du coach

Essentiel après les séances de fractionné ou de côtes.



Ischio-jambiers

Face arrière de la cuisse

30 sec × 3

Assis, jambe tendue, dos droit. Penche le buste vers l'avant depuis les hanches. Maintiens sans rebond, expire à chaque relâchement.

Note du coach

Ischio souple = moins de claquage et meilleure foulée.



Mollet et Achille

Gastrocnémien · Achille

45 sec × 3

Main contre mur, pied arrière à plat, genou tendu. Pousse le talon vers le sol. Faire les 2 versions : genou tendu puis fléchi.

Note du coach

À faire chaque soir, même sans blessure déclarée.



Bandelette IT

Hanche externe · BIT

30 sec × 3

Debout, croise la jambe à étirer derrière l'autre. Penche le buste du côté opposé en appuyant la hanche vers l'extérieur.

Note du coach

Indispensable dès 3+ séances par semaine.



Piriforme

Fessier profond · rotateurs

30 sec × 3

Allongé, cheville sur genou opposé. Tire la cuisse vers la poitrine. Sens l'étirement dans la fesse. Respire régulièrement.

Note du coach

Cause cachée de nombreuses douleurs de sciatique.



Fascia plantaire

Voûte plantaire · talon

60 sec × 2

Assis, tirer les orteils vers le tibia, tenir 30 sec. Masser ensuite la voûte avec une balle de tennis ou de golf.

Note du coach

À faire dès le réveil avant le premier pas au sol.

Règle d'or

Ne jamais s'étirer sur une douleur aiguë. Si une zone est douloureuse, consulte un kinésithérapeute. La douleur pendant un étirement n'est **jamais normale**.

Gestion de la charge

La **surcharge chronique** est la première cause de blessure. Le corps s'adapte si on lui laisse le temps. Règle d'or : n'augmenter qu'un seul paramètre à la fois.



Règle des 10%

N'augmente jamais le volume de plus de 10%/semaine. Cycle conseillé : 3 semaines de charge puis 1 semaine de décharge à -30%.



Signaux d'alarme

RPE constamment élevé, douleurs inhabituelles ou fatigue persistante au réveil sont des signaux à ne pas ignorer. Réduire la charge immédiatement.



Sommeil prioritaire

Moins de 7h multiplie par 2 le risque de blessure. Priorise le sommeil autant que l'entraînement. C'est la nuit que le corps se renforce.



Cycle de décharge

Toutes les 3 à 4 semaines, réduis le volume de 30 à 40%. La décharge planifiée déclenche la surcompensation et les progrès durables.

VARIABLES À SURVEILLER

Volume hebdomadaire		70%	+ 10% max / semaine
Intensité des séances		80%	Contrôle via fréquence cardiaque
Fréquence de séances		60%	Augmenter progressivement
Dénivelé positif		45%	Variable souvent négligée
Allure spécifique		35%	Introduire en phase finale
Récupération active		90%	Ne jamais sacrifier le repos

Comment lire ce tableau ?

Les % représentent l'importance relative de chaque variable. **Ne modifie jamais deux variables simultanément** : volume OU intensité, pas les deux en même temps.

Le cycle idéal



Sem. 1-3 : charge progressive +5 à +10%



Sem. 4 : décharge -30 à -40% du volume



Répéter avec un nouveau palier supérieur

Protocole PEACE & LOVE

Remplace l'ancien RICE. Il intègre les **dernières recherches en médecine du sport** pour une gestion complète et éprouvée des blessures aiguës.

P	Protection Limiter les activités douloureuses les 1 à 3 premiers jours. Repos relatif sans immobilisation totale pour éviter d'aggraver la lésion.
E	Élévation Élever le membre blessé au-dessus du niveau du cœur pour réduire l'enflure et accélérer le drainage lymphatique.
A	Anti-inflammatoires : non Dans les 72 premières heures, ils freinent l'inflammation naturelle essentielle à la cicatrisation. Les éviter sauf prescription médicale.
C	Compression Bandage compressif pour limiter l'œdème et soutenir les tissus. Serré sans couper la circulation : les doigts ne doivent pas bleuir.
E	Éducation Comprendre sa blessure pour mieux la gérer. La douleur est un signal utile. La reprise progressive est supérieure à l'arrêt total.
L	Loading progressif Reprendre la mise en charge dès que possible. Le mouvement contrôlé favorise la guérison et prévient la perte musculaire.
O	Optimisme L'état d'esprit positif influence directement la guérison. Les patients optimistes récupèrent plus vite et font moins de rechutes.
V	Vascularisation Cardio non douloureux (vélo, natation, marche) pour maintenir le flux sanguin et accélérer la cicatrisation des tissus.
E	Exercice ciblé Reprendre les exercices de renforcement spécifiques dès que possible. La rééducation active est supérieure au repos passif prolongé.

Chaussures et matériel

Le choix de la chaussure est souvent **sous-estimé**, pourtant c'est l'un des facteurs les plus importants dans la prévention des blessures du coureur.



Chaussure d'entraînement daily

Amorti modéré, durabilité maximale. Pour les footings quotidiens. À renouveler tous les 600 à 800 km : les propriétés amorties disparaissent avant que la semelle ne soit usée visuellement.



Chaussure de vitesse / plaquée

Carbone ou nylon rigide pour les séances intenses et compétitions. Ne pas utiliser pour les footings : le drop bas entraîne une surcharge tendineuse si l'usage est trop fréquent.



Trail et chaussure de stabilité

Drop bas et semelle adhérente pour le trail. Sur route, la chaussure de stabilité est recommandée en cas de pronation excessive confirmée par un podologue.



Rotation de 2 à 3 paires

Alternar plusieurs paires différentes réduit de 40% le risque de blessure selon les études. Chaque modèle sollicite différemment le pied et les articulations.



Bilan podologique régulier

Un bilan biomécanique est conseillé tous les 2 ans ou après une blessure répétée. Des semelles sur-mesure peuvent corriger des déséquilibres structurels importants.

Prêt à courir plus intelligent ?



Tu as maintenant toutes les clés. La prochaine étape : un plan structuré qui respecte tes capacités et te fait progresser sans te blesser.

Mes plans d'entraînement PDF



Plan 10 km
8 sem.

à partir de
14,99€



Plan 10 km
12 sem.

à partir de
14,99€



Semi-Marathon
12 sem.

à partir de
14,99€



Marathon
12 sem.

à partir de
14,99€



Marathon
16 sem.

à partir de
14,99€



Guide Anti-Blessure

Tu lis ce guide. Partage-le à un coureur qui en a besoin pour rester longtemps sur les routes.

14,99€



Coaching personnalisé

Plan 100% sur-mesure, suivi hebdomadaire et messagerie directe avec ton coach Alexis Elie.

à partir de 30€/mois



Rejoins The Ultimate Academy

Déjà **70 coureurs** qui progressent et courent sans blessure. Retrouve tous les plans et le coaching sur :

theultimateacademy.fr